Clínica AlergoVida, Alergia e Imunologia Clínica
Rua das Acácias, 120, Centro
Dr. Henrique Lacerda Moraes, CRM/MS 99.512

RELATÓRIO MÉDICO

Laudo médico para solicitação de omalizumabe. Data de emissão: 22/01/2026

Paciente: Valdirene Sousa Prado. **Idade:** entre 40 e 50 anos.

Relatório médico circunstanciado

Declaro, para os devidos fins, que a paciente Valdirene Sousa Prado está em acompanhamento médico especializado por quadro de **Urticária Crônica Espontânea (UCE)**, doença inflamatória cutânea crônica, com episódios recorrentes de urticas intensamente pruriginosas, de aparecimento espontâneo, e importante comprometimento da qualidade de vida, do sono e do bem-estar físico e emocional.

A paciente tem quadro persistente e refratário ao tratamento convencional otimizado, com atividade significativa da doença apesar da terapêutica em doses máximas recomendadas. Foi instituído tratamento com anti-histamínico H1 de segunda geração, **Bilastine em dose quadruplicada**, mantido por período superior a **4 meses**, sem controle adequado da doença e sem resposta clínica satisfatória.

A atividade da doença foi documentada por instrumentos validados internacionalmente:

- UAS7 (Urticaria Activity Score, 7 dias) em setembro/2025: 42 pontos, compatível com atividade grave;
- UAS7 atual: 27 pontos, atividade moderada a grave apesar do tratamento otimizado;
- UCT (Urticaria Control Test) atual: 3 pontos, doença completamente não controlada.

Foi feita investigação laboratorial complementar para excluir causas secundárias de urticária crônica, sem evidência de etiologia alternativa, o que corrobora o diagnóstico de Urticária Crônica Espontânea refratária.

Diagnóstico

Urticária Crônica Espontânea (CID-10: L50.1).

Justificativa técnica para omalizumabe

A paciente tem falha terapêutica documentada ao tratamento de primeira linha otimizado, tendo utilizado anti-histamínico H1 de segunda geração em dose até quatro vezes superior à habitual, conforme recomendado por consensos internacionais e nacionais para o manejo da urticária crônica espontânea.

Segundo diretrizes internacionais da urticária crônica (EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI), pacientes com UCE não controlada após uso

de anti-histamínicos em dose quadruplicada têm indicação formal de tratamento com Omalizumab, considerado terapia de escolha nesta etapa, com comprovada eficácia, segurança e melhora substancial do controle clínico e da qualidade de vida.

A persistência da atividade inflamatória expõe a paciente a intenso sofrimento físico e emocional, prurido persistente e lesões recorrentes, prejuízo do sono e da funcionalidade diária e necessidade potencial de corticosteroides sistêmicos de repetição, terapia não recomendada cronicamente pelos riscos cumulativos.

Diante da refratariedade demonstrada e da gravidade medida por escores validados, o uso do omalizumabe é medida médica necessária, baseada em evidências científicas e diretrizes internacionais, não havendo alternativa terapêutica disponível com eficácia comparável neste contexto clínico.

Prescrição médica

Omalizumab 300 mg, via subcutânea, a cada 4 semanas, por período inicial de 6 meses, com reavaliação clínica periódica por UAS7 e UCT.

Conclusão

A paciente tem Urticária Crônica Espontânea grave e não controlada, refratária ao tratamento convencional otimizado com anti-histamínico em dose quadruplicada, e preenche critério técnico-científico formal para uso de omalizumabe, tratamento imprescindível para controle da doença, prevenção de agravamento clínico e recuperação da qualidade de vida. Solicita-se com urgência o fornecimento do medicamento Omalizumabe 300 mg via subcutânea a cada 4 semanas, diante da necessidade clínica e da ausência de resposta às terapias previamente instituídas.

Dr. Henrique Lacerda Moraes
CRM/MS 99.512 (assinado digitalmente em 22/01/2026)